

Reporte y análisis sistémico de incidentes y eventos adversos

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Recoger hechos, analizar factores contribuyentes y aprender de fallas sin ocultar daños ni prejuzgar responsabilidades.

2. Alcance y condiciones de uso

Incluye incidentes sin daño, eventos con daño y eventos por dispositivos. Integra tecnovigilancia cuando corresponde, con sus plazos propios.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Priorizar atención del paciente, control del peligro y comunicación transparente

Priorizar atención del paciente, control del peligro y comunicación transparente. Registrar fecha, lugar, actividad, descripción y resultado con hechos; no alterar la historia original.

2. Clasificar incidente o evento y gravedad preliminar

Clasificar incidente o evento y gravedad preliminar. Conservar referencias a historia, equipo y lote; evitar datos personales innecesarios en reportes administrativos.

3. Recolectar información de quienes participaron, documentos y condiciones

Recolectar información de quienes participaron, documentos y condiciones. Reconstruir cronología y diferenciar lo observado de hipótesis o rumores.

4. Usar un análisis sistémico inspirado en el Protocolo de Londres: paciente, tarea, equipo h

Usar un análisis sistémico inspirado en el Protocolo de Londres: paciente, tarea, equipo humano, comunicación, entorno, tecnología y organización. Identificar problemas de atención y barreras, sin afirmar que el formato sustituye el método completo.

5. Definir acciones específicas que modifican causas y barreras, con responsable y plazo

Definir acciones específicas que modifican causas y barreras, con responsable y plazo. Evitar como única medida recordar al personal que tenga cuidado.

6. Verificar implementación y eficacia con observación o medida

Verificar implementación y eficacia con observación o medida. Informar al paciente conforme a su situación y preservar reserva; cumplir reporte externo aplicable y cerrar con evidencia.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Reporte inmediato de riesgo y gestión local oportuna.

Serios por dispositivo: canal y plazo específicos.

Indicador: acciones verificadas eficaces / acciones evaluadas x 100.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Fecha actividad y código reservado	
Hechos y consecuencias	
Control inmediato	
Clasificación	
Cronología	
Factores contribuyentes	
Barreras fallidas	
Acción responsable plazo	
Reporte externo y radicado	
Eficacia y cierre	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Tecnovigilancia

Resolución 4816 de 2008, artículos 12 y 14-16: responsable, información mínima y reporte; serios en 72 horas desde ocurrencia, no serios por consolidado trimestral, por canal aplicable al prestador.

https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_4816_2008.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576